Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5025033-75.2024.8.21.0010/RS

AUTOR: ISADORA MAGNAGUAGNO

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

ISADORA MAGNAGUAGNO ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA**, partes qualificadas na lide.

Narrou ser portadora de transtorno depressivo maior resistente ao tratamento (CID-10: F33.2), tendo feito uso dos mais diversos tratamentos, sem sucesso até o momento. Disse que sua condição se caracteriza por crises recorrentes de depressão profunda, acompanhadas de ideação suicida, o que tem comprometido severamente sua qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades cotidianas. Referiu que foi prescrito pela médica assistente, Dra. Maria Inês Kalil Juliano de Mesquita, psiquiatra, CREMERS 20122, a medicação SPRAVATO® (CLORIDRATO DE ESCETAMINA), destacando sua eficácia na rápida redução dos sintomas depressivos em casos de depressão resistente ao tratamento. A administração do medicamento deve ocorrer em um ambiente controlado, como um hospital ou clínica especializada, sob a supervisão de um profissional de saúde. Destacou que, apesar da urgência e da gravidade do quadro clínico, a requerida negou a cobertura do medicamento sob a alegação de que não possui Diretriz de Utilização Técnica (DUT) aprovada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Discorreu sobre o direito aplicável. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que a ré cubra o tratamento integral, mediante o fornecimento do medicamento SPRAVATO® (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) e demais medicamentos EVENTUALMENTE solicitados pelo médico e relacionados ao tratamento da doença da parte autora, bem como demais instrumentos necessários para aplicação, conforme prescrição médica, até a alta médica definitiva, sob pena de aplicação de multa diária. Postulou a concessão do benefício da AJG. Pediu a procedência da ação, com confirmação da liminar, com condenação da ré à cobertura integral do tratamento com fornecimento da medicação e demais instrumentos necessários para aplicação, conforme prescrição médica. Atribuiu à ré os ônus sucumbenciais. Juntou documentos - Evento 1.

Intimada, a autora juntou negativa da Unimed - Evento 6.

Concedido o benefício de assistência judiciária gratuita à parte autora. E deferida a tutela de urgência - Evento 8.

Rejeitado os embargos de declaração da autora - Eventos 12 e 14. Da decisão, a autora interpôs agravo de instrumento, o qual restou provido, sendo determinada expedição de mandado de intimação da Unimed - Evento 19.

A autora informou o descumprimento da medida liminar, requerendo a majoração da multa - Evento 24.

Juntada certidão de cumprimento do mandado - Evento 27.

Citada, a demandada contestou - Evento 30. Esclareceu que a autora é beneficiária de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial regulamentado, firmado com a requerida Unimed Nordeste. Disse que em 07 de maio de 2024 a requerida recebeu solicitação, de forma administrativa, de cobertura contratual para o fornecimento do medicamento SPRAVATO 140mg/m, em razão do diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT). Referiu que a Auditoria Médica concluiu pela negativa de cobertura em virtude de o medicamento postulado não atender aos requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) nº 109, conforme previsão do rol de procedimentos da ANS e, consequentemente, não havendo cobertura contratual. Impugnou o valor atribuído à causa, entendendo que deve ser atribuído o valor de alçada. No mérito, discorreu acerca da ausência de cobertura contratual legal. Disse que o medicamento solicitado pela autora não está coberto pelo plano de saúde para o caso em tela, por não estar contemplado na lista dos procedimentos obrigatórios, não havendo, portanto, obrigatoriedade alguma de custeio, do mesmo, por parte da operadora. Discorreu acerca da inexistência de abusividade e da taxatividade do rol da ANS. Sustentou a inexistência de urgência/emergência no procedimento sub judice. Alegou a ausência de evidência de eficácia científica. Impugnou a inversão do ônus da prova. Requereu o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa. Pediu a improcedência da causa, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais. Juntou documentos.

A autora informou que realizou a primeira aplicação da medicação. Requereu que a ré viabilize o fornecimento da segunda aplicação, com majoração da multa - Evento 33.

Intimada, a ré informou que está cumprindo integralmente a medida liminar, não reconhecendo os argumentos da petição da autora. Juntou documentos - Evento 40.

Rejeitada a preliminar de impugnação ao valor causa - Evento 48.

Intimadas, não houve interesse das partes na produção de outras provas.

Relatei. Decido.

Cabível o julgamento antecipado do feito no estado em que se encontra, na hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as partes não postularam outras provas.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a fornecer o medicamento Spravato – Cloridrato de Escetamina, em face do transtorno depressivo maior resistente ao tratamento, CID 10: F 33.2 que acomete a autora, conforme indicado pela médica assistente -evento 1, OUT11.

A demandada, por sua vez, referiu que o medicamento postulado não atende aos requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) nº 109, conforme previsão do rol de procedimentos da ANS e, consequentemente, não havendo cobertura contratual.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Consoante o laudo médico do assistente, Dra. Maria Ines Kalil Juliano de Mesquita CRM-RS: 20122 (Evento 1, OUT11), a autora tem diagnóstico Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), CID10 F33.2, e apresenta um quadro depressivo grave recorrente, com importante prejuízo na vida pessoal, social e laborativa. E apesar dos vários esquemas de tratamento, com escitalopran, vortioxetina, agomelatina, associados a esquema de potencialização com lítio ou aripiprazol, não obteve remissão dos sintomas. Inclusive já tentou suicídio em crise prévia.

No caso, o pedido de autorização para o fornecimento do tratamento foi recusado porque a doença CID F33.2 não se enquadra na Diretriz de Utilização nº 109, não havendo obrigatoriedade na cobertura assistencial **-evento 6, OUT2**.

Sendo assim, conforme a indicação clínida do seu Médico Assistente (Transtorno Depressivo Maior - CID F33.2), não se enquadra na Diretriz de Utilização nº 109. Portanto, não há obrigatoriedade de cobertura assistencial.

Segue diretriz abaixo, para sua apreciação:

109. ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO EM HOSPITAL-DIA PSIQUIÁTRICO

1. Cobertura obrigatória de acordo com o médico assistente, de programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, inclusive administração de medicamentos, quando preenchido pelos menos um dos seguintes critérios:
   a. paciente portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa (CID F10, F14);
   b. paciente portador de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29);
   c. paciente portador de transtornos do humor (episódio maníaco e transtorno bipolar do humor – CID F30, F31);
   d. paciente portador de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

Exposto isso, concluímos que o pedido de autorização do medicamento *Spravato 140MG* solicitado pelo seu Médico Assistente, **não** atende a Diretriz de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde, da ANS (Anexo II da RN nº 465/21, da ANS).

A Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022 que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim dispõe acerca do atendimento ambulatorial:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)**

Consoante a Lei n. 14.454, que alterou a lei 9.656/1998, editada em 21-9-2022, indica que o rol da ANS constitui referência básica no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, ou seja, é meramente exemplificativo.

"[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, **constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.**

§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

O medicamento Spravato possui registro na Anvisa[1], sendo indicado para as seguintes patologias:

"SPRAVATO® é indicado para Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina).

SPRAVATO® é indicado, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda.

Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO® na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida.

Mesmo que o paciente apresente melhoras com as doses iniciais de SPRAVATO, o uso de SPRAVATO não dispensa a necessidade de hospitalização, caso clinicamente justificada."

Conforme acima mencionado, a autora foi submetida a diversos tratamentos, porém, sem a eficácia desejada, havendo solicitação de urgência, em face do risco de suicídio -Evento 1, OUT11.

Oportuno esclarecer que a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica, *in verbis:*

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".

Dessa forma, cabe ao médico assistente, o qual é conhecedor do quadro clínico, determinar qual o tipo de tratamento mais adequado ao caso, prescrever os métodos e os procedimentos mais indicados para o paciente, bem como os materiais e medicamentos que deverão ser utilizados.

Ou seja, é vedado ao plano de saúde insurgir-se contra as determinações do médico quanto aos medicamentos e materiais utilizados no procedimento e que objetivam reduzir os riscos do paciente e, em consequência, os custos do plano de saúde, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, ainda, que haja recomendação pela Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Possuindo o contrato firmado pelas partes cobertura de tratamento para a moléstia apresentada pela parte autora, como no caso da presente demanda, não pode o plano, agora, negar-se a arcar com as despesas do medicamento indicado pelo médico da paciente, alegando a exclusão da cobertura para os procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, uma vez que preenchido todos os outros requisitos, quais sejam: cobertura para moléstia apresentada; medicamento descrito para indicação da bula; e o registro do medicamento na ANVISA.

Assim, havendo cobertura contratual para a moléstia apresentada pela parte autora e estando o medicamento indicado pelo médico assistente registrado na ANVISA, incumbe ao plano de saúde demandado fornecer o medicamento prescrito, restando superada a questão da taxatividade do rol da ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.

Nesse sentido, é o posicionamento do TJ/RS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO POR ATENDENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que evidenciada a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida. Havendo cobertura contratual para a doença, as operadoras estão contratualmente obrigadas a custear o tratamento respectivo, não podendo se sobrepor à prescrição médica. Súmula *n*. 608 do STJ e art. 47 do CDC. **No caso, apesar de a terapia prescrita não estar prevista no** *Rol* **de Procedimentos e Eventos em Saúde da** *ANS***, há expressa indicação médica do tratamento, com informação sobre sua eficácia. Ainda, as divergências acerca da taxatividade do** *Rol* **da** *ANS* **estão superadas a partir da promulgação da** *Lei n. 14.454***, de 21 de setembro de 2022, em vigor desde tal data e que altera o art. 10 da** *Lei n***. 9.656/98.** Acompanhamento terapêutico em ambiente escolar que deve ser realizado pelos profissionais da clinica da qual o recorrente é paciente ao menos desde seus 2 (dois) anos de idade, a preservar, assim, a continuidade do tratamento, fator fundamental para sua evolução social, mental e motora. Decisão antecipatória confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51260743820228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 26-10-2022). [Grifei].

Assim, tenho por evidenciada a responsabilidade do plano de saúde demandado pela cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente à parte autora, devendo arcar com os valores do medicamento Spravato - *Fase de indução: 24 dispositivos com 28mg cada; Fase de manutenção: 72 dispositivos com 28mg cada*, conforme a prescrição médica - Evento 1, OUT11.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PLEITO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO *SPRAVATO* (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). *MEDICAMENTO* DE *USO AMBULATORIAL*. ART. 12, I, ALÍNEA "B", DA LEI 9.656/98. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE *PLANO* DE *SAÚDE*, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS *MÉDICOS* POR *PLANOS* DE *SAÚDE* SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM *SAÚDE* PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE *SAÚDE* SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS *PLANOS* PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À *SAÚDE*, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022, A QUAL POSSUI APLICABILIDADE IMEDIATA, SOBRETUDO AOS TRATAMENTOS DE CARÁTER CONTINUADO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS *PLANOS* DE *SAÚDE* ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO *MÉDICO* ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. OUTROSSIM, CONSISTINDO EM TRATAMENTO DE *USO AMBULATORIAL*, AFIGURA-SE OBRIGATÓRIA A COBERTURA, POR SE TRATAR DE EXIGÊNCIA MÍNIMA DE FORNECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 12, I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 9.656/98. 6. ADEMAIS, DENOTA-SE A EXISTÊNCIA DE NOTAS TÉCNICAS Nº 93152 E Nº 103074, EXTRAÍDAS DO SISTEMA E-NATJUS QUE DEMONSTRAM A EFICÁCIA À LUZ DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE O DEMANDANTE. 7. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A *MEDICAMENTO* PRESCRITO PELA *MÉDICA* ASSISTENTE, CONHECEDORA DAS PECULIARIDADES DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA E PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM *SAÚDE* DA ANS, ASSIM COMO TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E *PLANO* TERAPÊUTICO, ATRAINDO O DISPOSTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98, REPUTANDO-SE, AO REVERSO DO SUSTENTADO PELA OPERADORA RÉ, ABSOLUTAMENTE INDEVIDA EVENTUAL INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50288051720228210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. *PLANO* DE *SAÚDE*. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. *MEDICAMENTO* ESCETAMINA. ALEGAÇÃO DE *USO* DOMICILIAR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA E MULTA PARA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. 1) É lícito que se excetue o fornecimento de *medicamentos* para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de *saúde* (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo *medicamentos* para o controle de efeitos adversos

relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo *médico* assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 2) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de *plano* de *saúde*, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os *medicamentos* de *uso* domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de *medicamentos* domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 3) Caso dos autos em que, a partir da bula do *medicamento* - nome comercial *Spravato* -, afere-se a descaracterização do *uso* domiciliar, vez que deve ser administrado em estabelecimento de *saúde*, por profissional da área da *saúde*, que deverá monitorar o paciente após administração. 4) A tese defendida pela parte ré - ausência de cobertura de *medicamento* domiciliar - não se aplica ao caso em questão, vez que o *medicamento* postulado, cuja eficácia para a patologia da autora foi reconhecida na origem (preclusão), não é de *uso* domiciliar, mas sim *ambulatorial* com supervisão de um profissional da área da *saúde*. 5) Relativamente às astreintes, entendo que sua fixação visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação. 6) Considerando que o provimento recursal refere-se à medida urgente, para cobertura de *medicamento* considerado indispensável para tratar o transtorno da autora, possível e necessária a fixação de prazo e multa para o caso de eventual descumprimento. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.(Apelação Cível, Nº 51192934520228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-08-2023)

Por fim, registro que não houve descumprimento da medida liminar, já que intimada no dia 17-6-2024 - Evento 27, CERTGM1, foi administrada a medicação na mesma data-evento 40, OUT6, seguindo as aplicações periódicas conforme docuemntos juntados no Evento 40.

Isso posto, confirmando a liminar deferida, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação proposta por **ISADORA MAGNAGUAGNO** contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.,** com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte ré à cobertura integral do tratamento indicado à parte autora - Spravato, *Fase de indução: 24 dispositivos com 28mg cada; Fase de manutenção: 72 dispositivos com 28mg cada*, a ser administrado junto à unidade de saúde, conforme prescrição médica -evento 1, OUT11, com custeio das despesas pelo respectivo plano de saúde.

Pelo princípio da sucumbência, imponho à demandada o pagamento das despesas processuais, mais honorários ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, a ser corrigido pelo IPCA a contar desta sentença, e a partir do trânsito em julgado incidirá correção monetária e juros de mora unicamente pela Taxa Selic, observado o regramento dos art.389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil, com alteração dada pela lei nº14.905 de 28-6-2024, em razão do singelo desenrolar da causa e demais critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Intimações agendadas no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 28/10/2024, às 17:40:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10070760601v11** e o código CRC **dc5fe5fa**.

---

1. https://www.gov.↩br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/spravato-r-cloridrato-de-escetamina-novo-registo ↩